

輸液管理

(1) 滴下数の計算法

① 使用する点滴セットの「1mlあたりの滴下数」を確認する

微量用セットは 1ml、60滴 その他のセットは 1ml、20滴

* 総輸液量800ml以下で24時間を維持する時は、微量用セットを使用する

② 以下の計算式に、上記で調べた「60滴」または「20滴」を当てはめる

1分間の滴下

=

点滴セットの1mlあたりの滴下

×

輸液量

指示時間(分)

③ 「1分間の滴下数」早見表 輸液500mlの場合

指示時間	20滴/1ml	60滴/1ml	指示時間	20滴/1ml	60滴/1ml
1時間	166	500	7時間	23.8	71.4
2時間	83.3	250	8時間	20.8	62.5
3時間	55.5	166.7	9時間	18.5	55.6
4時間	41.6	125	10時間	16.6	50
5時間	33.3	100	11時間	15.1	45.4
6時間	27.7	83.3	12時間	13.8	41.7

(2) 点滴の管理、観察ポイント

- ①速度は指示通りに行う。
- ②ナースコールは患者の手の届くところにおいて声かけをする。
- ③ルート of 接続部が抜けないようにきちんと接続を確認する。
- ④点滴中は巡視し、部位の腫脹、気分不良、点滴速度の変化、ルート抜去の有無を確認する。
特に、体動の激しい患者、小児、高齢者、意識障害のある患者へは、自己抜去、注射薬の漏れ、ルート of 閉塞等に注意し、こまめに訪室して観察する。
- ⑤次に交換する点滴ボトルを点滴スタンドにかけっぱなしにしない。
- ⑥刺入部～点滴ボトルまでの、すべてのルートを確認し、異常がないことを確認する。
- ⑦ルートが複数ある場合は、接続部にテープをはり、薬剤名を記載する。
- ⑧遮光は原則不要であるが、直射日光が長時間あたるとなれば、カーテンを引くなど、日光が当たらないような工夫をする。
- ⑨ニトログリセリンやニトロールは、薬剤の輸液セットへの吸着防止の為にPVCフリーの輸液セットを使用する。
- ⑩薬剤は、必ず、1患者1トレイで準備し、複数の患者の物を1つのトレイに置かない。

点滴速度の変化に影響を及ぼす因子

- ・患者の体位又は肢位、ラインの状況、輸液の濃度などで、滴下速度は変化する。
- ・肢位で滴下が変化しやすい時は、頻回に観察するが、ルートをとりにおすことも考慮する。
- ・滴下チェック時は、実際の輸液残量から計算し、適切に滴下しているか判断する。
- ・速度を調節したときは、その後の滴下に変化が見られる場合がある為、調節幅、残量等を考慮して忘れずに滴下の再チェックを実施する。